Estilo UERJ

Simulado 3 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

80 questões

15 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 80 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 4 horas, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 46 anos, natural de Salvador, vive com HIV há 10 anos, em TARV regular, com carga viral indetectável e CD4 de 620 células/mm³. Procura atendimento por sede intensa, constipação e sonolência há 1 semana e placas eritematosas descamativas no tronco há 2 meses. Exame: linfonodos cervicais e axilares de 2 a 3 cm, fígado a 4 cm do rebordo costal. Exames: cálcio total 14,2 mg/dL, albumina 3,8 g/dL, PTH 6 pg/mL (VR 15 a 65), 1,25-di-hidroxivitamina D baixa, PTHrP elevado, creatinina 1,8 mg/dL, leucócitos 38.000/mm³ com 70% de linfócitos atípicos de núcleo convoluto e multilobulado, LDH 1.100 U/L. Imunofenotipagem do sangue periférico: CD3+, CD4+, CD25+, CD7 negativo. O agente etiológico mais provavelmente implicado é:

A) Herpesvírus humano 8

B) Vírus Epstein-Barr

C) HIV por ação oncogênica direta

D) HTLV-1

---

2 Homem de 54 anos tem gota, com três crises de podagra e uma de joelho nos últimos 12 meses, a última resolvida há 3 semanas com colchicina. É hipertenso e usava hidroclorotiazida, trocada por losartana há 1 mês. Sem tofos ao exame e sem litíase renal. Exames: ácido úrico 9,4 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL (TFGe 92 mL/min/1,73 m²), ALT e hemograma normais. Será iniciado alopurinol. Quanto à dose inicial do alopurinol e à profilaxia das crises, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) 300 mg/dia / sem profilaxia

B) 300 mg/dia / colchicina por 3 a 6 meses

C) 100 mg/dia / sem profilaxia

D) 100 mg/dia / colchicina por 3 a 6 meses

---

3 Homem de 63 anos, pedreiro, tabagista (40 maços-ano), tem dor intensa no ombro direito irradiada pela face medial do braço e do antebraço até o 4º e o 5º dedos há 4 meses, com piora noturna e sem melhora com anti-inflamatório e fisioterapia. Perdeu 6 kg. Radiografia de tórax em PA feita há 2 meses, laudada como normal. Ressonância de coluna cervical: protrusão discal C5-C6 sem compressão radicular significativa e uncoartrose difusa. Exame: atrofia dos interósseos e da eminência hipotenar à direita, hipoestesia na face medial do antebraço direito, pupila direita menor que a esquerda, com ptose palpebral discreta à direita e menos sudorese na hemiface direita. Reflexos bicipitais e tricipitais simétricos. A causa mais provável do quadro é:

A) Siringomielia cervical

B) Síndrome do desfiladeiro torácico

C) Tumor do sulco pulmonar superior

D) Radiculopatia por hérnia discal cervical

---

4 Em adulto com doença renal crônica não dialítica (TFGe 24 mL/min/1,73 m²), hemoglobina de 9,2 g/dL, VCM de 86 fL, saturação de transferrina de 17%, ferritina de 340 ng/mL, sem sangramento e sem uso prévio de agente estimulador da eritropoese, a primeira medida para a anemia é:

A) Iniciar alfaepoetina

B) Reposição de ferro

C) Alfaepoetina associada a ferro

D) Transfusão de hemácias

---

5 Rapaz de 17 anos, 1,92 m, com envergadura maior que a altura, aracnodactilia, sinais do punho e do polegar positivos, pectus excavatum e ectopia lentis bilateral operada aos 12 anos. O pai morreu aos 41 anos de dissecção de aorta. Assintomático, joga vôlei na escola. PA 118×64 mmHg, FC 68 bpm. Ecocardiograma de triagem feito há 8 meses: raiz da aorta de 31 mm (escore Z +1,4), aorta ascendente normal, sem refluxo aórtico, função ventricular normal. Ao auscultá-lo deitado e, em seguida, em pé, o achado mais provável e o efeito da mudança para a posição de pé são, respectivamente:

A) Sopro diastólico paraesternal direito / mais intenso

B) Clique mesossistólico / mais precoce

C) Clique mesossistólico / mais tardio

D) Sopro diastólico paraesternal direito / inalterado

---

6 Homem de 71 anos, ex-tabagista, há 4 meses com disfagia progressiva para sólidos e depois para líquidos, regurgitação e perda de 11 kg. Endoscopia digestiva alta: esôfago discretamente dilatado, com resíduos, e resistência leve à passagem do aparelho pela junção esofagogástrica, cuja mucosa é normal à visão direta e na retrovisão; biópsias da cárdia sem neoplasia. Esofagograma baritado: afilamento distal em bico de pássaro. Manometria de alta resolução: pressão de relaxamento integrada da junção esofagogástrica de 28 mmHg e pressurização panesofágica em 100% das deglutições. O próximo passo mais adequado é:

A) Dilatação pneumática da cárdia

B) Toxina botulínica na cárdia

C) Ecoendoscopia da cárdia

D) Miotomia endoscópica peroral

---

7 Em município do Baixo Tocantins (PA), em plena epidemia de dengue, um homem de 34 anos procura atendimento com febre diária há 12 dias, cefaleia, mialgia, edema de face e de membros inferiores e dispneia aos esforços há 3 dias. Outros quatro membros da família, que tomaram juntos açaí comprado de um vendedor ambulante há cerca de 3 semanas, têm quadro semelhante. Não há lesão de porta de entrada nem edema palpebral unilateral. Exame: T 38,2 °C, FC 118 bpm, PA 104 × 68 mmHg, edema facial e de membros inferiores, estertores em bases, terceira bulha. Hb 12,8 g/dL, leucócitos 9.200/mm³ com linfocitose, plaquetas 168.000/mm³, ALT 84 U/L. ECG: taquicardia sinusal, baixa voltagem e alterações difusas da repolarização. Ecocardiograma: derrame pericárdico pequeno e FE 45%. NS1 e IgM para dengue não reagentes. O exame mais adequado para confirmar o diagnóstico nesta fase é:

A) RT-PCR para dengue

B) Sorologia IgG para T. cruzi

C) Hemoculturas para bactérias

D) Pesquisa direta do parasito no sangue

---

8 Homem de 46 anos procura atendimento por cefaleia frontal há oito meses e perda de libido e disfunção erétil há dois anos. Exame: hemianopsia temporal bilateral à confrontação, ginecomastia discreta, sem galactorreia, testículos de volume normal. Ressonância magnética: macroadenoma hipofisário de 4,3 cm, com invasão do seio cavernoso direito e compressão do quiasma óptico. Exames: prolactina 62 ng/mL (até 15), testosterona total 98 ng/dL (300 a 1.000), LH 1,1 UI/L, cortisol às 8 horas 16,8 µg/dL, T4 livre 0,9 ng/dL (0,8 a 1,8), IGF-1 normal para a idade. A neurocirurgia programa cirurgia transesfenoidal para a próxima semana por adenoma não funcionante com desconexão de haste. Antes de decidir, o exame mais adequado é:

A) Prolactina com diluição da amostra

B) Teste de estímulo com cosintropina

C) Pesquisa de macroprolactina

D) Nenhum exame antes da cirurgia

---

9 Homem de 52 anos, transplantado renal há 6 anos, usa tacrolimo, azatioprina 100 mg/dia e prednisona 5 mg/dia, com creatinina estável de 1,5 mg/dL e hemograma normal há 2 meses. Teve três crises de gota no último ano e, há 4 semanas, outro médico iniciou alopurinol 300 mg/dia, com colchicina 0,5 mg/dia como profilaxia. Há 5 dias apresenta febre de 38,4 °C, odinofagia e úlceras orais. Exame físico: FC 108 bpm, PA 112 × 70 mmHg, mucosite oral, sem exantema, sem linfonodomegalias, enxerto indolor. Exames: Hb 7,9 g/dL, VCM 108 fL, leucócitos 900/mm³ (neutrófilos 200/mm³), plaquetas 41.000/mm³, reticulócitos 0,2%, creatinina 1,6 mg/dL, AST e ALT normais, eosinófilos ausentes. PCR quantitativo para citomegalovírus no sangue: 380 cópias/mL, mesmo valor de 6 meses antes. A causa mais provável da pancitopenia é:

A) Infecção por citomegalovírus

B) Mielotoxicidade da colchicina

C) Interação do alopurinol com a azatioprina

D) Reação de hipersensibilidade ao alopurinol

---

10 Gestante de 31 anos, 34 semanas, com miastenia gravis generalizada AChR positiva estável com piridostigmina 60 mg de 6/6 h, é internada com PA 168/112 mmHg, cefaleia e proteinúria de 2,1 g/24 h. Recebe nifedipino oral e a medicação padrão para prevenção de eclâmpsia, em dose de ataque IV seguida de infusão contínua. Duas horas depois apresenta ptose bilateral, disfagia, fraqueza cervical e dispneia, com CVF caindo de 2,8 L para 1,4 L. Reflexos patelares presentes, FC 88 bpm, pupilas normais, sem fasciculações, sem sialorreia, lacrimejamento ou cólicas. A causa mais provável da piora é:

A) Efeito do nifedipino na junção neuromuscular

B) Exacerbação própria do terceiro trimestre

C) Bloqueio neuromuscular pelo sulfato de magnésio

D) Crise colinérgica pela piridostigmina

---

11 Homem de 57 anos procura atendimento por dor lombar há 3 meses, sem déficit neurológico. Ressonância de coluna: lesão expansiva única no corpo vertebral de T11, com componente de partes moles, sem compressão medular e sem instabilidade. Biópsia guiada por tomografia: infiltrado de plasmócitos monoclonais kappa. Exames: Hb 13,8 g/dL, cálcio 9,5 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, pico monoclonal IgG kappa de 0,4 g/dL, razão de cadeias leves livres kappa/lambda de 3,1. PET-CT de corpo inteiro sem outras lesões. Biópsia de medula óssea da crista ilíaca com plasmócitos clonais em 6%. A conduta mais adequada é:

A) Radioterapia local em dose curativa

B) Ressecção cirúrgica isolada da vértebra

C) Indução de mieloma e transplante autólogo

D) Observação com eletroforese seriada

---

12 Homem de 68 anos, ex-tabagista há 5 anos (55 maços-ano), com DPOC em uso regular e com técnica correta de tiotrópio e olodaterol, teve no último ano duas exacerbações tratadas com antibiótico e prednisona em domicílio. Não tem tosse produtiva crônica nem história de asma. Teve pneumonia há 8 meses, tratada em enfermaria. Espirometria pós-broncodilatador: VEF1/CVF 0,52, VEF1 54% do previsto. Eosinófilos no sangue de 70/mm³ e de 80/mm³ em duas dosagens fora de exacerbação. ECG: QTc 420 ms. Audiometria normal. Além de manter a dupla broncodilatação e a reabilitação, a conduta mais adequada para reduzir exacerbações é:

A) Acrescentar budesonida inalatória

B) Acrescentar azitromicina contínua

C) Acrescentar roflumilaste

D) Acrescentar dupilumabe

---

13 Mulher de 76 anos, hipertensa, obesa (IMC 34 kg/m²), com fibrilação atrial permanente em uso de rivaroxabana e metoprolol, volta ao ambulatório 1 mês após internação por IC descompensada. Hoje em NYHA II, euvolêmica com furosemida 40 mg ao dia, PA 132×78 mmHg, FC 74 bpm. TFG 52 mL/min, potássio 4,4 mEq/L. Ecocardiograma: hipertrofia concêntrica, átrio esquerdo de 52 mm, E/e' de 16, PSAP de 44 mmHg e fração de ejeção de 52%. NT-proBNP 1.480 pg/mL. Para reduzir nova hospitalização por IC, a medicação a acrescentar com maior nível de recomendação é:

A) Enalapril

B) Espironolactona

C) Sacubitril-valsartana

D) Dapagliflozina

---

14 Homem de 79 anos com adenocarcinoma de próstata metastático para ossos, em cuidados de fim de vida domiciliares (PPS 30%), usa morfina de liberação regular 10 mg a cada 4 horas há 3 semanas, sem mudança de dose, e recebeu ontem à noite, por insônia, amitriptilina 25 mg prescrita pelo plantão. Há 8 horas está agitado, tenta sair da cama, puxa o cateter de hipodermóclise e geme ao ser tocado no abdome. Exame: Tax 36,7 °C, FC 104 bpm, PA 150 × 90 mmHg, desatento, sem mioclonias; massa suprapúbica dolorosa, macicez até a cicatriz umbilical; última diurese há 10 horas. Glicemia capilar 118 mg/dL. A causa mais provável da agitação é:

A) Retenção urinária aguda

B) Dor óssea não controlada

C) Neurotoxicidade por morfina

D) Delirium terminal

---

15 Homem de 52 anos, lavrador desde a infância no interior do estado do Rio de Janeiro, tabagista de 40 maços-ano e etilista, procura atendimento por lesões dolorosas na boca há 4 meses, com dificuldade para mastigar, rouquidão, tosse e perda de 10 kg. Exame: lesões ulceradas de fundo granuloso com pontilhado hemorrágico fino em gengiva, palato e lábio inferior; linfonodos submandibulares de 2 cm, endurecidos; estertores esparsos à ausculta. Radiografia de tórax: infiltrado reticulonodular bilateral e simétrico em campos médios, com ápices e bases poupados. Baciloscopia de escarro negativa em 2 amostras. Anti-HIV não reagente. O exame que, isoladamente, pode confirmar o diagnóstico mais provável de forma mais rápida e menos invasiva é:

A) Exame micológico direto do raspado

B) Biópsia da lesão com histopatologia

C) Sorologia por imunodifusão dupla

D) TRM-TB no escarro

---

16 Mulher de 52 anos, com transtorno bipolar em uso de carbonato de lítio há nove anos (litemia de 0,6 mEq/L há um mês) e carcinoma de mama tratado há três anos, em uso de tamoxifeno, procura atendimento por sede intensa e diurese de cerca de 6 litros por dia, iniciadas de forma abrupta há cinco semanas. Exames: glicemia de jejum 92 mg/dL, cálcio 9,4 mg/dL, potássio 4,1 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, sódio 145 mEq/L. Teste de restrição hídrica: após seis horas, sódio 148 mEq/L, osmolalidade plasmática 304 mOsm/kg e osmolalidade urinária 140 mOsm/kg. Uma hora após 2 µg de desmopressina subcutânea, a osmolalidade urinária subiu para 460 mOsm/kg. O diagnóstico mais provável é:

A) Polidipsia primária

B) Diabetes insípido nefrogênico pelo lítio

C) Diurese osmótica

D) Diabetes insípido central

---

17 Homem de 58 anos, com melanoma metastático, recebe ipilimumabe e nivolumabe há dez semanas. Há duas semanas tem cefaleia, astenia intensa, anorexia e náuseas. Sem febre ou diarreia. Exame: PA 96/60 mmHg, FC 104 bpm, sem hiperpigmentação, tireoide sem bócio. Exames: sódio 128 mEq/L, potássio 4,4 mEq/L, glicemia 72 mg/dL, cortisol às 8 horas 1,9 µg/dL, ACTH 6 pg/mL (10 a 60), TSH 0,22 µUI/mL (0,4 a 4,5), T4 livre 0,6 ng/dL (0,8 a 1,8), testosterona baixa com LH baixo. Ressonância de sela: aumento difuso e homogêneo da hipófise, com espessamento da haste. O diagnóstico e a primeira medida terapêutica são, respectivamente:

A) Tireoidite por imunoterapia / levotiroxina

B) Hipofisite / levotiroxina

C) Tireoidite por imunoterapia / hidrocortisona

D) Hipofisite / hidrocortisona

---

18 Mulher de 52 anos, submetida a gastroplastia com derivação em Y de Roux há 9 anos, procura atendimento por dor óssea difusa em quadris, costelas e pernas há 8 meses, com dificuldade para subir escadas e marcha anserina. Há 1 ano, por T-escore de -2,8 em colo femoral, outro médico iniciou alendronato 70 mg/semana e carbonato de cálcio 500 mg/dia, com piora progressiva da dor desde então. Usa polivitamínico de forma irregular. Exame físico: dor à compressão do esterno e das costelas, força 4 em flexores do quadril. Exames: cálcio 8,3 mg/dL (albumina 3,9 g/dL), fósforo 2,1 mg/dL, fosfatase alcalina 410 U/L (VR até 120), GGT normal, PTH 168 pg/mL, creatinina 0,7 mg/dL, calciúria 40 mg/24 h. Radiografia de bacia: faixas radiotransparentes perpendiculares à cortical nos ramos púbicos, bilaterais e simétricas. O diagnóstico que explica a piora é:

A) Osteomalácia por má absorção

B) Osteoporose refratária ao bisfosfonato

C) Hiperparatireoidismo primário

D) Fratura atípica por bisfosfonato

---

19 Homem de 74 anos, hipertenso, tem anemia macrocítica há 1 ano e passou a precisar de 2 concentrados de hemácias por mês nos últimos 3 meses. Não há sangramento. Vitamina B12, folato, cobre, TSH e função hepática normais; não consome álcool nem usa drogas mielotóxicas. Mielograma: medula hipercelular, diseritropoese em 30% dos eritroblastos, blastos 2%, sem sideroblastos em anel. Cariótipo normal, sem mutação de SF3B1 ou TP53. Hemograma: Hb 7,9 g/dL, VCM 104 fL, neutrófilos 2.100/mm³, plaquetas 160.000/mm³. IPSS-R de baixo risco (2,5 pontos). Eritropoetina sérica endógena de 140 U/L e ferritina de 620 ng/mL. A conduta mais adequada é:

A) Azacitidina subcutânea

B) Transplante alogênico de medula

C) Quelação de ferro isolada

D) Alfaepoetina

---

20 Homem de 66 anos, hipertenso e tabagista, acorda às 7 h com a boca 'torta' para a esquerda e babando ao beber café; foi dormir às 23 h sem queixas, após dormir com a janela aberta numa noite fria. Nega dor retroauricular, hiperacusia e alteração do paladar. Exame: apagamento do sulco nasolabial direito e queda da comissura labial à direita; franze a testa e eleva as sobrancelhas simetricamente e fecha os olhos com força igual dos dois lados; disartria discreta; força 5/5 e coordenação normal nos membros. PA 172/96 mmHg, glicemia 118 mg/dL, otoscopia normal. O próximo passo mais adequado é:

A) Prednisona oral por 10 dias

B) Prednisona com valaciclovir oral

C) Eletroneuromiografia em 72 horas

D) Neuroimagem de crânio com urgência

---

21 Mulher de 52 anos, sem comorbidades, está internada há 36 horas por pancreatite aguda biliar (lipase 2.400 U/L; ultrassonografia com colelitíase múltipla, colédoco de 7 mm, sem cálculo visível no colédoco). Na admissão: bilirrubina total 3,1 mg/dL, fosfatase alcalina 260 U/L, ALT 410 U/L. Recebeu Ringer lactato em ritmo moderado e analgesia, e já aceita dieta oral leve. Hoje: Tax 36,8 °C, FC 84 bpm, PA 124 × 78 mmHg, anictérica, dor abdominal leve. Exames: leucócitos 9.800/mm³, bilirrubina total 1,4 mg/dL, ALT 190 U/L, creatinina 0,8 mg/dL. Escore BISAP 1. Quanto à CPRE e ao momento da colecistectomia, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) CPRE em 24 horas / após 6 semanas

B) CPRE em 24 horas / na mesma internação

C) Sem CPRE / após 6 semanas

D) Sem CPRE / na mesma internação

---

22 Homem de 70 anos, ex-tabagista (50 maços-ano), em uso de amiodarona 200 mg/dia há 3 anos por fibrilação atrial, refere dispneia progressiva há 1 ano. Nega tosse, febre e perda de peso. Exame: tórax em tonel, murmúrio vesicular difusamente reduzido, sem estertores em velcro, sem baqueteamento. TC de tórax: enfisema centrolobular nos lobos superiores, sem reticulado, vidro fosco ou faveolamento. Espirometria pós-broncodilatador: CVF 60% do previsto, VEF1 57% do previsto, VEF1/CVF 0,72. Pletismografia: CPT 116% do previsto, VR 205% do previsto, VR/CPT 0,64. DLCO 48% do previsto. O distúrbio funcional que explica a redução da CVF é:

A) Distúrbio misto obstrutivo e restritivo

B) Aprisionamento aéreo por obstrução

C) Restrição parenquimatosa por amiodarona

D) Restrição extraparenquimatosa

---

23 Homem de 45 anos é internado com meningite; o Gram do líquor mostra diplococos Gram-positivos e a cultura identifica Streptococcus pneumoniae. Mora com a esposa e dois filhos de 8 e 12 anos, vacinados conforme o calendário, e divide uma sala fechada com três colegas de trabalho. Quanto à quimioprofilaxia dos contactantes, o correto é:

A) Rifampicina para os domiciliares

B) Não indicada para nenhum contactante

C) Ciprofloxacino para domiciliares e colegas

D) Ceftriaxona dose única para os filhos

---

24 Mulher de 24 anos teve o primeiro e único surto de febre reumática aos 16 anos, com cardite, e ficou com insuficiência mitral leve, estável nos ecocardiogramas anuais. Usa penicilina G benzatina a cada 21 dias, sem falhas. Pela diretriz brasileira, a profilaxia secundária deve ser mantida até:

A) Os 21 anos, já cumpridos

B) Os 25 anos

C) Os 26 anos

D) Os 40 anos

---

25 Homem de 66 anos, com diabetes tipo 2, hipertensão e doença renal crônica (TFGe 46 mL/min/1,73 m², relação albumina/creatinina 480 mg/g), em uso de anlodipino, metformina e dapagliflozina. Há três semanas iniciou ramipril, titulado para 10 mg/dia. Nega anti-inflamatório, diarreia ou vômitos. Exame: PA 132/80 mmHg (era 154/92), sem hipotensão postural, sem edema, sem sopro abdominal. Nunca teve edema agudo de pulmão. Exames de hoje comparados aos de antes do ramipril: creatinina de 1,40 para 1,70 mg/dL, potássio de 4,9 para 5,4 mEq/L, bicarbonato 23 mEq/L, relação albumina/creatinina de 480 para 210 mg/g. A conduta mais adequada é:

A) Suspender o ramipril

B) Trocar o ramipril por losartana

C) Manter o ramipril e repetir exames

D) Investigar estenose de artéria renal

---

26 Mulher de 42 anos procurou a UPA há cinco dias por palpitações e foi medicada com metimazol 20 mg/dia e propranolol. Retorna com piora de dor na região anterior do pescoço, irradiada para a mandíbula e o ouvido esquerdo, iniciada três semanas após um quadro gripal, e febre baixa. Usou ibuprofeno 600 mg três vezes ao dia por quatro dias, sem melhora da dor. Exame: T 37,9 °C, FC 92 bpm, tireoide endurecida, dolorosa à palpação, sem nódulos. Exames: TSH 0,01 µUI/mL, T4 livre 3,4 ng/dL (0,8 a 1,8), T3 total 210 ng/dL (80 a 200), VHS 92 mm/h, TRAb negativo, leucócitos 9.800/mm³. Ultrassonografia: áreas hipoecogênicas mal definidas, com fluxo reduzido ao Doppler. Além de manter o propranolol, a conduta mais adequada é:

A) Manter metimazol e associar prednisona

B) Suspender metimazol e iniciar prednisona

C) Manter metimazol e trocar o anti-inflamatório

D) Suspender metimazol e programar iodo radioativo

---

27 Mulher de 49 anos procura atendimento por poliartrite simétrica de mãos e punhos há 4 meses, com rigidez matinal de 1 hora, e, há 6 semanas, tosse seca e dispneia aos médios esforços. Refere febre baixa intermitente e dedos que ficam brancos e roxos no frio. Nega lesões em pálpebras, disfagia e fraqueza para subir escadas. Exame físico: sinovite em metacarpofalângicas e punhos, pele espessada, fissurada e hiperceratótica nas faces radiais dos indicadores e polegares, estertores em velcro bibasais, força muscular grau 5. Exames: fator reumatoide 48 UI/mL (VR < 14), anti-CCP não reagente, FAN 1:160 com padrão citoplasmático pontilhado fino, CK 410 U/L (VR até 170), VHS 50 mm/h. Radiografia de mãos sem erosões. TC de tórax: vidro fosco e reticulação basais e subpleurais, com consolidações peribroncovasculares, padrão de pneumonia intersticial não específica com componente em organização. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome antissintetase

B) Doença mista do tecido conjuntivo

C) Artrite reumatoide com pneumopatia intersticial

D) Esclerose sistêmica com pneumopatia intersticial

---

28 Mulher de 68 anos, com artrite reumatoide há 10 anos e DRC estágio 3b (creatinina basal de 1,7 mg/dL), usa "um remédio semanal, tomado aos domingos, e ácido fólico às segundas", além de prednisona 5 mg/dia. Há 8 dias recebeu na UPA um antibiótico para cistite, de nome que não lembra, "dois comprimidos grandes por dia". Hoje chega com úlceras orais dolorosas, febre de 38,4 °C e equimoses. Exames: Hb 7,9 g/dL, VCM 108 fL, leucócitos 900/mm³ (neutrófilos 300/mm³), plaquetas 22.000/mm³, creatinina 2,1 mg/dL, AST 88 U/L. Esfregaço: neutrófilos hipersegmentados. Além de suspender as drogas e iniciar antibiótico de largo espectro, a conduta mais adequada é:

A) Ácido fólico em dose alta

B) Vitamina B12 intramuscular

C) Ácido folínico endovenoso

D) Filgrastim isolado

---

29 Mulher de 19 anos, previamente hígida, sem uso de medicamentos, chás ou álcool, tem icterícia progressiva há 10 dias e, há 2 dias, sonolência e desorientação. Exame: ictérica, com asterixis, sem estigmas de hepatopatia crônica, Tax 36,9 °C. Exames: hemoglobina 7,9 g/dL, reticulócitos 9%, DHL 980 U/L, teste de Coombs direto negativo, bilirrubina total 28 mg/dL (direta 12 mg/dL), AST 196 U/L, ALT 64 U/L, fosfatase alcalina 22 U/L (40 a 130), INR 3,4, creatinina 1,9 mg/dL. Sorologias para hepatites A, B, C e E negativas, paracetamol sérico indetectável, FAN e antimúsculo liso negativos. O diagnóstico mais provável e a conduta definitiva são, respectivamente:

A) Hepatite autoimune fulminante / pulsoterapia com corticoide

B) Hepatite autoimune fulminante / transplante hepático de urgência

C) Doença de Wilson / D-penicilamina

D) Doença de Wilson / transplante hepático de urgência

---

30 Homem de 24 anos, com epilepsia focal controlada com carbamazepina (última crise há 3 anos), foi atendido ontem à noite no PS por vômitos após uma festa, recebeu duas doses de metoclopramida 10 mg IV e teve alta com metoclopramida oral. Retorna 14 horas depois, angustiado, porque os olhos 'travam para cima' por vários minutos e o pescoço se estende e gira para a direita contra a vontade. Responde às perguntas durante os episódios e se lembra de tudo; fala com dificuldade pela contração da mandíbula. PA 132/80 mmHg, FC 104 bpm, Tax 36,8 °C, sem rigidez muscular generalizada, sem déficit focal. Glicemia 96 mg/dL, sódio 139 mEq/L. A conduta mais adequada é:

A) Biperideno IV

B) Aumentar a dose de carbamazepina

C) Dantroleno IV

D) Fenitoína IV em dose de ataque

---

31 Um teste para detectar uma doença tem sensibilidade de 90% e especificidade de 90%. Ele será usado como rastreio numa população em que a prevalência da doença é de 1%. Entre as pessoas com resultado positivo nessa população, a proporção que de fato tem a doença é, aproximadamente:

A) 1%

B) 8%

C) 90%

D) 99%

---

32 Mulher de 74 anos, no 9º dia de internação por pneumonia aspirativa tratada com clindamicina e ceftriaxona, em uso de omeprazol, evolui com distensão abdominal progressiva, dor difusa e febre. Teve duas evacuações amolecidas no 6º dia; desde então não evacua nem elimina flatos. Exame: T 38,6 °C, FC 122 bpm, PA 84 × 50 mmHg após 2 L de cristaloide, iniciada noradrenalina; abdome distendido, timpânico, doloroso, ruídos hidroaéreos ausentes, sem peritonite. Leucócitos 34.000/mm³, creatinina 2,4 mg/dL (basal 0,8), lactato 4,0 mmol/L. TC de abdome: cólon transverso com 7 cm, espessamento parietal difuso com sinal do acordeão, sem pneumoperitônio. PCR para o gene da toxina B de C. difficile em swab retal positiva. A cirurgia geral avaliou e acompanha. Além da suspensão da clindamicina, o tratamento antimicrobiano mais adequado é:

A) Metronidazol intravenoso isolado

B) Vancomicina oral 125 mg de 6/6 horas

C) Vancomicina oral e retal com metronidazol IV

D) Vancomicina intravenosa com meropenem

---

33 Mulher de 61 anos, hipertensa, chega a um hospital sem hemodinâmica com dor torácica há 2 horas e supradesnivelamento de ST de V1 a V5. O serviço de referência com angioplastia fica a 3 horas de transporte. Recebe AAS, clopidogrel, enoxaparina e tenecteplase 25 minutos após a chegada. Aos 70 minutos da fibrinólise está sem dor, com redução de 70% do supradesnivelamento na derivação de maior elevação, e o monitor registra ritmo idioventricular acelerado a 88 bpm, autolimitado. PA 124×76 mmHg, Killip I. A conduta mais adequada em relação à estratégia invasiva é:

A) Cateterismo eletivo após a alta

B) Cateterismo só se houver isquemia induzida

C) Angioplastia de resgate imediata

D) Cateterismo entre 2 e 24 horas

---

34 Em mulher de 47 anos, imunocompetente, submetida há 6 anos a histerectomia total por miomatose, com histopatológico do colo uterino sem neoplasia intraepitelial e citopatológicos anteriores normais, a conduta quanto ao rastreamento do câncer do colo do útero é:

A) Citologia da cúpula a cada 3 anos

B) Encerrar o rastreamento

C) Teste de DNA-HPV a cada 5 anos

D) Colposcopia anual da cúpula

---

35 Mulher de 52 anos, com infecções urinárias de repetição, procura o pronto-socorro por dor em flanco direito há dois dias, febre de 39,2 °C e calafrios. Exame: PA 104/62 mmHg após 2 litros de cristaloide, FC 112 bpm, punho-percussão lombar direita dolorosa. Exames: leucócitos 19.800/mm³, creatinina 1,8 mg/dL, lactato 2,8 mmol/L; urina com pH 8,0, nitrito positivo, leucocitúria intensa e bacilos gram-negativos no Gram. Tomografia sem contraste: cálculo de 9 mm no ureter proximal direito com hidronefrose moderada e cálculo coraliforme parcial no rim direito. Já recebeu a primeira dose de ceftriaxona. A composição mais provável do cálculo coraliforme e a conduta urológica imediata são, respectivamente:

A) Ácido úrico / ureteroscopia com litotripsia

B) Ácido úrico / drenagem com duplo J ou nefrostomia

C) Estruvita / ureteroscopia com litotripsia

D) Estruvita / drenagem com duplo J ou nefrostomia

---

36 Homem de 27 anos tem dor lombar inflamatória há 14 meses, com rigidez matinal de 1 hora, melhora com exercício e despertar na segunda metade da noite. Há 2 meses recebeu diagnóstico de espondilite anquilosante (sacroiliíte bilateral grau 3 na radiografia, HLA-B27 reagente). Usou paracetamol sem melhora e, depois, ibuprofeno 400 mg quando a dor apertava, em média uma vez ao dia, por 3 semanas, com alívio parcial. Sem artrite periférica, entesite, uveíte, psoríase ou sintomas intestinais. Função renal normal, sem doença péptica, PA 122 × 78 mmHg. BASDAI 5,8, PCR 2,4 mg/dL. A conduta mais adequada é:

A) Associar sulfassalazina

B) Naproxeno em dose plena contínua

C) Prednisona 20 mg/dia

D) Iniciar adalimumabe

---

37 Mulher de 32 anos tem plaquetopenia descoberta em hemograma admissional, sem queixas. Nega sangramentos, tem menstruação normal e não usa medicamentos, álcool ou fitoterápicos. Exame físico: sem petéquias, sem linfonodomegalia, baço não palpável. Exames: Hb 13,0 g/dL, leucócitos 6.200/mm³ com diferencial normal, plaquetas 41.000/mm³ (confirmadas em tubo com citrato), VCM 88 fL. Esfregaço: plaquetas grandes, sem esquizócitos e sem blastos. Sorologias para HIV, hepatite C e hepatite B negativas, TSH normal, TP e TTPa normais, antígeno fecal de H. pylori negativo, teste de gravidez negativo. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Mielograma antes de decidir

B) Observação com hemograma seriado

C) Prednisona 1 mg/kg/dia

D) Imunoglobulina humana endovenosa

---

38 Mulher de 34 anos tem nódulo tireoidiano de 2,1 cm cuja punção mostrou carcinoma medular, com calcitonina sérica de 380 pg/mL e CEA de 18 ng/mL. O pai foi operado de tumor de tireoide aos 40 anos e morreu subitamente durante uma colecistectomia. Nega cefaleia, palpitações ou sudorese. Exame: PA 122/78 mmHg, FC 78 bpm, sem linfonodos cervicais palpáveis. Exames: cálcio 9,4 mg/dL, PTH 38 pg/mL. Ultrassonografia cervical sem linfonodos suspeitos. Pesquisa do proto-oncogene RET: mutação no códon 634. Antes da tireoidectomia, o exame indispensável é:

A) Metanefrinas livres plasmáticas

B) Tomografia de tórax e abdome

C) Cintilografia com sestamibi

D) PET-CT com FDG

---

39 Mulher de 48 anos, 1,55 m de altura e 98 kg, intubada há 20 horas por pneumonia por influenza com síndrome do desconforto respiratório agudo. Ventilação controlada a volume: volume corrente 500 mL, PEEP 12 cmH2O, FiO2 80%, FR 22 irpm. Pressão de platô 33 cmH2O, pressão de pico 40 cmH2O. Gasometria: pH 7,31, PaCO2 50 mmHg, PaO2 88 mmHg. Sedada, sem drogas vasoativas. Radiografia: opacidades bilaterais. O ajuste do volume corrente e a medida adicional mais adequada são, respectivamente:

A) Manter 500 mL / ECMO venovenosa

B) Manter 500 mL / posição prona

C) Reduzir para cerca de 290 mL / ECMO venovenosa

D) Reduzir para cerca de 290 mL / posição prona

---

40 Homem de 41 anos, pedreiro, previamente hígido e sem uso de medicações, procura a emergência 5 horas depois de pisar descalço num prego enferrujado, em terreno com entulho e esterco. Exame: T 36,6 °C, ferimento perfurante de cerca de 1,5 cm de profundidade na planta do pé direito, com terra no trajeto, sem sinais flogísticos e sem tecido desvitalizado extenso. Glicemia capilar 96 mg/dL. Traz a caderneta de vacinação: três doses na infância, reforços aos 15 e aos 25 anos e, por último, uma dose de dT aos 34 anos, quando cortou a mão numa obra. Nega alergia a vacinas. Foi feita a limpeza com soro fisiológico e a retirada de corpos estranhos. Quanto à profilaxia do tétano, a conduta mais adequada é:

A) Reforço de dT com imunoglobulina antitetânica

B) Apenas a limpeza, sem vacina

C) Reforço de dT, sem imunoglobulina

D) Esquema completo de três doses de dT

---

41 Homem de 52 anos, com diabetes tipo 2 mal controlado, procura o PS por cefaleia progressiva há 3 semanas, febre baixa vespertina e, há 4 dias, visão dupla e sonolência. Exame: Glasgow 14, rigidez de nuca, paresia do VI nervo à esquerda, sem outros déficits. TC de crânio com contraste: discreta dilatação ventricular e realce meníngeo basal. Líquor: 210 células/mm³ (78% linfócitos), proteína 290 mg/dL, glicose 96 mg/dL, Gram, tinta da China e antígeno criptocócico negativos. Glicemia sérica colhida no mesmo momento: 384 mg/dL. HIV não reagente. Sem história de neoplasia. A etiologia mais provável é:

A) Meningite tuberculosa

B) Meningite carcinomatosa

C) Meningite viral

D) Meningite bacteriana decapitada

---

42 Homem de 61 anos com carcinoma renal de células claras e metástases pulmonares pequenas e estáveis, em uso de pembrolizumabe e axitinibe, ECOG 1, tem dor dorsal progressiva há 10 dias, pior ao deitar, e há 24 horas fraqueza nas pernas. Exame: força grau 4 em membros inferiores, hiperreflexia patelar, nível sensitivo em T8; deambula com apoio. RM de toda a coluna: lesão lítica única em T7, com colapso de 50% do corpo vertebral, retropulsão de fragmento ósseo e compressão medular; SINS 13; sem outras lesões. A medida imediata e o tratamento definitivo mais adequados são, respectivamente:

A) Dexametasona / radioterapia isolada

B) Aguardar biópsia / radioterapia isolada

C) Aguardar biópsia / descompressão seguida de radioterapia

D) Dexametasona / descompressão seguida de radioterapia

---

43 Mulher de 44 anos refere dor difusa há 2 anos, nos dois hemicorpos, acima e abaixo da cintura e no esqueleto axial, com cansaço, sono não reparador e dificuldade de concentração. Nega artrite, rigidez matinal prolongada, fraqueza, febre, perda de peso, fotossensibilidade, úlceras orais e Raynaud. Exame físico: dor à palpação em múltiplos pontos musculares, sem sinovite, força grau 5, pele e mucosas normais. Exames: hemograma, VHS, PCR, CK, TSH, cálcio, 25-hidroxivitamina D, glicemia, função renal e função hepática normais. Trouxe FAN de laboratório externo: reagente 1:80, padrão nuclear pontilhado fino. Índice de dor generalizada 9 e escala de gravidade dos sintomas 7. Quanto à investigação, o mais adequado é:

A) Repetir o FAN em 6 meses

B) Nenhum exame adicional

C) Eletroneuromiografia e biópsia muscular

D) Anti-DNA nativo, anti-Sm e complemento

---

44 Homem de 27 anos, com deficiência intelectual, fendas palpebrais oblíquas para cima, prega palmar única e hipotireoidismo em uso de levotiroxina, é trazido pela irmã por cansaço progressivo. Ela conta que na infância havia um sopro alto no coração e que a cirurgia foi adiada e depois esquecida. Exame: cianose de lábios e extremidades, baqueteamento digital, SpO2 82% em ar ambiente, impulsão sistólica paraesternal esquerda, B2 única e intensa no foco pulmonar, sopro diastólico decrescente em borda esternal esquerda alta e nenhum sopro sistólico audível. Hemoglobina 20,1 g/dL. ECG: ritmo sinusal, PR de 220 ms, eixo do QRS em -60 graus e sobrecarga ventricular direita. O defeito de base e a fisiologia atual são, respectivamente:

A) DSAV / síndrome de Eisenmenger

B) DSAV / shunt da esquerda para a direita

C) CIV / síndrome de Eisenmenger

D) CIA ostium secundum / síndrome de Eisenmenger

---

45 Mulher de 45 anos tem diagnóstico há 2 anos de trombocitemia essencial com mutação de CALR, sem trombose prévia e sem fatores de risco cardiovascular, em acompanhamento sem medicação. Procura atendimento por epistaxe recorrente e menorragia há 1 mês. PA 122 × 78 mmHg. Exames: Hb 11,2 g/dL, leucócitos 9.800/mm³, plaquetas 1.720.000/mm³, TP e TTPa normais, fator de von Willebrand antigênico 62% e atividade (cofator de ristocetina) 18%. A conduta mais adequada é:

A) AAS em dose baixa

B) Citorredução associada a AAS

C) Citorredução sem AAS

D) Manter observação

---

46 Mulher de 22 anos, sem doenças prévias e sem uso de medicações, é trazida ao pronto-socorro 10 horas após uma festa em que usou ecstasy e bebeu cerca de quatro litros de água. Teve uma crise tônico-clônica generalizada de dois minutos, presenciada, que cessou espontaneamente. Na chegada está sonolenta, Glasgow 12, sem déficit focal, e vomitou duas vezes. PA 136/84 mmHg, FC 102 bpm, temperatura 37,3 °C, glicemia capilar 104 mg/dL. Exames: sódio 117 mEq/L, potássio 3,8 mEq/L, osmolalidade plasmática 246 mOsm/kg, osmolalidade urinária 470 mOsm/kg, sódio urinário 64 mEq/L, CPK 380 U/L. Tomografia de crânio sem lesões. A conduta inicial mais adequada é:

A) Restrição hídrica e sódio em 4 horas

B) Salina a 3% 150 mL em bolus

C) SF 0,9% 1.000 mL em uma hora

D) Fenitoína intravenosa em dose de ataque

---

47 Homem de 47 anos, diabético, em hemodiálise por fístula arteriovenosa, sem cateter, é internado por febre e calafrios há 6 dias. Exame na admissão: T 38,7 °C, FC 108 bpm, PA 124 × 70 mmHg, sopro holossistólico 3+/6 em foco mitral, sem estertores ou edema, hemorragias subungueais em dois dedos, exame neurológico normal. Hemoculturas: Staphylococcus aureus em 4 de 4 frascos, sensível a oxacilina. Recebe vancomicina desde a admissão, com hemoculturas de controle do 3º dia negativas. No 5º dia de antibiótico, tem dor súbita em hipocôndrio esquerdo, e a TC mostra infarto esplênico. Ecocardiograma transesofágico no 6º dia: vegetação móvel de 14 mm no folheto anterior da valva mitral, regurgitação mitral moderada, sem abscesso, FE 60%. RM de crânio sem lesões. Sem sinais de insuficiência cardíaca. O antibiótico definitivo e a conduta cirúrgica são, respectivamente:

A) Vancomicina / antibiótico isolado

B) Vancomicina / cirurgia precoce

C) Oxacilina / antibiótico isolado

D) Oxacilina / cirurgia precoce

---

48 Homem de 64 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida (FE 30%) por cardiopatia isquêmica, sem diabetes, usa sacubitril-valsartana, bisoprolol, espironolactona e dapagliflozina 10 mg, esta acrescentada há dois meses. Sem poliúria nova ou sede. Exames de rotina: glicemia de jejum 91 mg/dL, HbA1c 5,5%, creatinina 1,28 mg/dL (era 1,15 antes da dapagliflozina), potássio 4,8 mEq/L, bicarbonato 24 mEq/L, fósforo 3,4 mg/dL, ácido úrico 4,9 mg/dL. Urina tipo 1: glicose 4+, proteína negativa, pH 5,5, sem leucocitúria. Diante da glicosúria, a conduta mais adequada é:

A) Suspender a dapagliflozina e repetir a urina

B) Pesquisa de tubulopatia proximal

C) Teste oral de tolerância à glicose

D) Nenhuma investigação adicional

---

49 Mulher de 56 anos, IMC 46 kg/m², hipertensa, com trombose venosa profunda de perna esquerda há 5 anos (tratada por 6 meses), ronco alto e sonolência diurna, procura atendimento por dispneia progressiva e edema de membros inferiores há 8 meses. Exame: SpO2 88% em ar ambiente, FC 92 bpm, B2 hiperfonética, turgência jugular, edema bilateral simétrico. Gasometria arterial em vigília, em ar ambiente: pH 7,37, PaO2 58 mmHg, PaCO2 54 mmHg, HCO3 31 mEq/L. Ecocardiograma: PSAP 58 mmHg, VD dilatado, FE do VE 64%, átrio esquerdo normal, função diastólica normal. Cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão sem defeitos de perfusão. Espirometria: VEF1/CVF 0,82, CVF 74% do previsto. A causa mais provável da hipertensão pulmonar é:

A) Tromboembólica crônica (grupo 4)

B) Doença cardíaca esquerda (grupo 2)

C) Hipertensão arterial pulmonar idiopática (grupo 1)

D) Hipoventilação e hipoxemia (grupo 3)

---

50 Homem de 63 anos com DM2 há 22 anos, neuropatia periférica e gastroparesia diagnosticada há 3 anos, usa metformina 2 g/dia (há 15 anos), insulina NPH e omeprazol. Há 8 meses tem distensão abdominal pós-prandial, flatulência e 3 a 4 evacuações amolecidas por dia, com perda de 5 kg. Sem sangue e sem febre. Exame: hipotensão postural, abdome distendido e timpânico, sem massas. Exames: hemoglobina 11,2 g/dL, VCM 104 fL, vitamina B12 168 pg/mL (200 a 900), folato sérico 26 ng/mL (3 a 17), anti-transglutaminase IgA negativo com IgA total normal, TSH normal, calprotectina fecal 38 µg/g, elastase fecal 380 µg/g. Colonoscopia normal, com biópsias normais. A causa mais provável da diarreia é:

A) Colite microscópica

B) Supercrescimento bacteriano do delgado

C) Insuficiência pancreática exócrina

D) Efeito adverso da metformina

---

51 Homem de 39 anos, internado na enfermaria há 2 dias por fraqueza ascendente iniciada 6 dias após quadro diarreico, com arreflexia global e dissociação proteinocitológica no líquor, recebe imunoglobulina IV (2º de 5 dias). Hoje refere dificuldade para engolir e tosse fraca. Exame: tetraparesia grau 2 em membros inferiores e 3 em superiores, paresia facial bilateral, não consegue contar até 15 numa expiração. FR 22 irpm, SpO2 97% em ar ambiente, PA oscilando entre 90/60 e 170/100 mmHg nas últimas 6 horas. Gasometria arterial: pH 7,41, pCO2 40 mmHg, pO2 88 mmHg. Capacidade vital forçada à beira do leito: 17 mL/kg (na admissão, 35 mL/kg). A conduta mais adequada neste momento é:

A) Repetir gasometria em 6 horas

B) Intubação orotraqueal eletiva na UTI

C) Ventilação não invasiva na UTI

D) Associar metilprednisolona à imunoglobulina

---

52 Mulher de 58 anos tem síndrome de Sjögren primária há 12 anos (anti-Ro e anti-La reagentes), com xerostomia e xeroftalmia, em uso de pilocarpina e colírio lubrificante. Há 5 meses nota aumento progressivo e indolor da parótida esquerda, que não regrediu com dois ciclos de antibiótico prescritos em outro serviço. Nega febre, dor à mastigação, saída de pus pelo ducto e perda de peso. Há 3 meses surgiram lesões purpúricas palpáveis nas pernas. Exame físico: parótida esquerda aumentada, endurecida e indolor, parótida direita normal, sem linfonodomegalias cervicais, púrpura palpável em pernas. Exames: Hb 12,1 g/dL, leucócitos 3.600/mm³ com linfócitos 700/mm³, plaquetas 210.000/mm³, VHS 48 mm/h, PCR 0,4 mg/dL, C3 normal, C4 5 mg/dL (VR 10 a 40), fator reumatoide 340 UI/mL, crioglobulinas positivas, eletroforese de proteínas com pequeno pico monoclonal IgM kappa. Ultrassonografia: parótida esquerda com área hipoecoica de 2,8 cm. O diagnóstico mais provável para o aumento da parótida é:

A) Sialadenite pela síndrome de Sjögren

B) Doença relacionada à IgG4

C) Linfoma MALT da parótida

D) Parotidite bacteriana crônica

---

53 Mulher de 29 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado há 4 anos, é internada por dor em hipocôndrio direito e ascite iniciadas há 10 dias. Refere urina escura pela manhã em alguns dias do último ano e episódios de disfagia. O Doppler mostra trombose das veias hepáticas. Exames: Hb 8,6 g/dL, VCM 102 fL, reticulócitos 4% (110.000/mm³), leucócitos 3.100/mm³, plaquetas 92.000/mm³, LDH 1.450 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 2,2 mg/dL, Coombs direto negativo, esfregaço sem esquizócitos, ferritina 18 ng/mL e hemossiderina urinária positiva. Fator V Leiden e mutação G20210A da protrombina ausentes. O exame mais adequado para elucidar o quadro é:

A) Citometria de fluxo (CD55, CD59)

B) Pesquisa de mutação JAK2 V617F

C) Proteínas C, S e antitrombina

D) Biópsia de medula com cariótipo

---

54 Homem de 26 anos, que faz sexo com homens, procura o serviço para iniciar PrEP. Relata relação anal receptiva sem preservativo com parceria de sorologia desconhecida há 16 dias. Há 4 dias tem febre, odinofagia, mialgia, úlceras orais rasas e exantema maculopapular em tronco. Exame: T 38,3 °C, linfonodos cervicais e axilares de 1,5 cm, faringe hiperemiada, exantema em tronco. Teste rápido anti-HIV (dois testes sequenciais) não reagente hoje. Creatinina 0,9 mg/dL, HBsAg não reagente, VDRL não reagente. Para decidir sobre a PrEP, o exame mais adequado neste momento é:

A) Imunoensaio de 3ª geração

B) Sorologia para EBV

C) Carga viral do HIV

D) Nenhum exame adicional

---

55 Homem de 58 anos, previamente hígido, refere há três semanas febre baixa, artralgias, perda de 4 kg e escarros com raias de sangue; há dois dias, dispneia. Exame: SpO2 89% em ar ambiente, FR 26 irpm, PA 158/94 mmHg, estertores crepitantes bilaterais, sem lesões cutâneas. Exames: hemoglobina 8,4 g/dL (12,9 g/dL há um mês), plaquetas 310.000/mm³, coagulograma normal, creatinina 1,1 mg/dL há dois meses, 3,8 mg/dL na admissão e 4,6 mg/dL após 24 horas, potássio 5,1 mEq/L; urina com 70% de hemácias dismórficas e cilindros hemáticos. Tomografia de tórax: opacidades em vidro fosco bilaterais. ANCA e anti-MBG foram colhidos, com resultado previsto em 72 horas, e a nefrologia agendou a biópsia renal para daqui a quatro dias. O início do tratamento e a biópsia renal são, respectivamente:

A) Pulsoterapia imediata / biópsia nos próximos dias

B) Aguardar sorologias / biópsia nos próximos dias

C) Pulsoterapia imediata / biópsia dispensada

D) Aguardar sorologias / biópsia dispensada

---

56 Homem de 23 anos, sem comorbidades, chega com palpitações há 1 hora. Relata dois episódios de taquicardia regular nos últimos 3 anos, revertidos na emergência com verapamil IV. Exame: lúcido, sem dispneia, PA 116×74 mmHg, perfusão adequada, FC entre 190 e 260 bpm. ECG: ritmo irregularmente irregular, complexos QRS de largura e morfologia variáveis de um batimento para outro, alguns estreitos e outros muito largos, menor intervalo RR de 200 ms. Potássio e magnésio normais. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

A) FA com aberrância / verapamil IV

B) TV polimórfica / sulfato de magnésio IV

C) FA pré-excitada / procainamida IV

D) FA pré-excitada / amiodarona IV

---

57 Homem de 61 anos, tabagista (30 maços-ano), com artrite reumatoide soropositiva há 14 anos, em uso de metotrexato e prednisona 5 mg/dia, tem derrame pleural à direita há 3 meses, com dor torácica leve. O irmão, com quem divide a casa, terminou o tratamento de tuberculose pulmonar há 4 meses. Nega febre e sudorese. Exame: T 36,8 °C, nódulos subcutâneos em cotovelos, sinovite em punhos, macicez no terço inferior do hemitórax direito. Toracocentese: líquido turvo esverdeado, pH 7,04, glicose 8 mg/dL (glicemia 104 mg/dL), proteína 5,2 g/dL, LDH 1.840 U/L, 2.300 células/mm³ (68% linfócitos), ADA 52 U/L, Gram e cultura para germes comuns negativos, pesquisa direta de BAAR e teste rápido molecular negativos. O diagnóstico mais provável é:

A) Linfoma pleural

B) Empiema pleural

C) Derrame pleural reumatoide

D) Tuberculose pleural

---

58 Mulher de 64 anos, tratada há 3 anos de carcinoma de mama luminal A estádio I (cirurgia conservadora, radioterapia e anastrozol em curso), assintomática, tem cálcio total de 11,4 mg/dL (8,5 a 10,2) em exames de rotina, confirmado com cálcio iônico de 1,48 mmol/L. Usa anastrozol e losartana; nega suplemento de cálcio ou de vitamina D e tiazídico. Exame normal. Exames: fósforo 2,3 mg/dL, albumina 4,2 g/dL, creatinina 0,8 mg/dL, PTH 58 pg/mL (15 a 65), 25-OH-vitamina D 32 ng/mL, cálcio urinário de 24 h 290 mg, fosfatase alcalina normal. Cintilografia óssea de seguimento, há 2 meses, sem lesões. A causa mais provável da hipercalcemia é:

A) Metástases ósseas osteolíticas

B) Hipercalcemia humoral pelo PTHrP

C) Hiperparatireoidismo primário

D) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

---

59 Mulher de 29 anos, com vitiligo, procurou a unidade básica há cinco semanas por cansaço, inchaço e queda de cabelo; TSH 9,8 µUI/mL, T4 livre 0,7 ng/dL (0,8 a 1,8), anti-TPO positivo, e iniciou levotiroxina 75 µg/dia. Há dez dias tem piora progressiva da astenia, náuseas, vômitos, dor abdominal e tontura ao levantar. Nega febre, diarreia ou viagem. Exame: PA 84/50 mmHg deitada, FC 118 bpm, mucosas secas, escurecimento de cicatrizes antigas e de pregas palmares, tireoide sem bócio, sem tremor. Exames: sódio 126 mEq/L, potássio 5,9 mEq/L, glicemia 61 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL, cálcio 9,6 mg/dL. A causa mais provável da descompensação atual é:

A) Hipotireoidismo ainda não compensado

B) Crise adrenal precipitada pela levotiroxina

C) Tireotoxicose por excesso de levotiroxina

D) Gastroenterite com desidratação

---

60 Mulher de 36 anos, parda, com diagnóstico de esclerose múltipla feito há 2 anos em outro serviço após neurite óptica bilateral grave (acuidade final 20/200 no olho direito), usa fingolimode há 8 meses. Nesse período teve 3 semanas de soluços e vômitos incoercíveis, com endoscopia normal, e agora apresenta, há 5 dias, paraparesia, nível sensitivo em T6 e retenção urinária. RM de coluna: lesão centromedular com hipersinal em T2 de C7 a T8, com realce. RM de encéfalo: lesão na área postrema, sem lesões periventriculares ovoides ou justacorticais. Bandas oligoclonais ausentes no líquor. Além da pulsoterapia com metilprednisolona, o exame a solicitar agora é:

A) Potencial evocado visual

B) Anticorpo anti-aquaporina-4 sérico

C) Nova RM de encéfalo em 3 meses

D) Pesquisa de vírus JC no líquor

---

61 Estudante de 21 anos, previamente hígido, iniciou há 12 dias tosse seca, cefaleia e febre baixa; a radiografia mostrou infiltrado intersticial bilateral e ele recebeu sulfametoxazol-trimetoprima por 5 dias, sem melhora, trocado depois por azitromicina. Hoje procura atendimento por urina escura e cansaço, e conta que as pontas dos dedos ficam arroxeadas no frio. Exame: icterícia 1+/4, SpO2 95%, crepitações em bases. Hemograma automatizado: Hb 8,1 g/dL, hematócrito 16%, VCM 124 fL, CHCM 50 g/dL, reticulócitos 7%. LDH 980 U/L, haptoglobina indetectável, bilirrubina indireta 3,4 mg/dL. Coombs direto: anti-C3d positivo, anti-IgG negativo. Esfregaço: aglutinação de hemácias, sem esquizócitos e sem corpúsculos de Heinz. O mecanismo da hemólise é:

A) Hemolisina bifásica de Donath-Landsteiner

B) IgM anti-I fixadora de complemento

C) IgG anti-Rh com sequestro esplênico

D) Oxidação da hemoglobina por sulfonamida

---

62 Mulher de 29 anos tem LES com nefrite classe IV diagnosticada há 7 semanas, tratada com pulso de metilprednisolona seguido de prednisona 60 mg/dia (hoje 50 mg/dia) e micofenolato 2 g/dia, sem profilaxia antimicrobiana. Há 6 dias apresenta tosse seca, febre de 38,3 °C e dispneia progressiva, hoje aos mínimos esforços. Nega hemoptise, dor torácica e edema. Exame físico: FR 30 irpm, SpO2 85% em ar ambiente, PA 118 × 72 mmHg, estertores finos discretos em bases, sem turgência jugular, sem edema. Exames: Hb 10,4 g/dL (10,6 g/dL há 1 semana), leucócitos 6.100/mm³ com linfócitos 350/mm³, plaquetas 196.000/mm³, LDH 690 U/L, creatinina 1,1 mg/dL (1,9 ao diagnóstico), EAS com 4 hemácias por campo (60 ao diagnóstico), C3 e C4 normais (baixos ao diagnóstico), anti-DNA nativo 1:40 (1:640 ao diagnóstico). TC de tórax: vidro fosco difuso, bilateral e simétrico, com predomínio peri-hilar e preservação da periferia, sem consolidações, nódulos ou derrame. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumonite lúpica aguda

B) Hemorragia alveolar lúpica

C) Edema pulmonar hipervolêmico

D) Pneumonia por Pneumocystis jirovecii

---

63 Homem de 36 anos, com HIV diagnosticado nesta internação, CD4 28 células/mm³, trabalhou nos últimos 3 meses na reforma de um casarão abandonado no interior de Minas Gerais. Há 6 semanas tem febre diária, perda de 9 kg, diarreia e tosse seca. O irmão, com quem divide o quarto, tratou tuberculose pulmonar no ano passado. Exame: T 38,8 °C, PA 100 × 64 mmHg, linfonodos cervicais de 1,5 cm, fígado a 4 cm e baço a 5 cm do rebordo costal, pápulas umbilicadas e úlceras rasas em face e palato. Hb 8,2 g/dL, leucócitos 2.100/mm³, plaquetas 64.000/mm³, LDH 1.480 U/L, ferritina 8.900 ng/mL, ALT 88 U/L, fosfatase alcalina 610 U/L, antígeno criptocócico sérico não reagente. Radiografia de tórax: infiltrado micronodular difuso. Baciloscopia de escarro negativa em 2 amostras. O agente mais provável é:

A) Complexo Mycobacterium avium

B) Cryptococcus neoformans

C) Histoplasma capsulatum

D) Mycobacterium tuberculosis

---

64 Homem de 66 anos chega 3 horas após o início de dor torácica, com supradesnivelamento de ST de V1 a V6, DI e aVL. PA 76×50 mmHg, FC 112 bpm, extremidades frias, enchimento capilar de 5 segundos, estertores em bases, SpO2 91% com oxigênio, lactato 4,8 mmol/L, sem sopros novos. Ecocardiograma à beira do leito: acinesia anterior extensa, FE 25%, sem complicação mecânica, sem derrame. No cateterismo, há oclusão da descendente anterior proximal e lesões de 80% na coronária direita e na circunflexa. O suporte hemodinâmico inicial e a estratégia de revascularização são, respectivamente:

A) Balão intra-aórtico / só a artéria culpada

B) Noradrenalina / só a artéria culpada

C) Noradrenalina / multiarterial no mesmo procedimento

D) Balão intra-aórtico / multiarterial no mesmo procedimento

---

65 Mulher de 56 anos, com hepatite C crônica adquirida por transfusão em 1988, foi tratada com sofosbuvir e velpatasvir por 12 semanas. Antes do tratamento: elastografia hepática transitória de 6,2 kPa, plaquetas 248.000/mm³, FIB-4 de 1,1 e ultrassonografia normal. Doze semanas após o fim do tratamento, HCV-RNA indetectável e ALT normal. Não usa álcool, IMC 23 kg/m², sem diabetes; HBsAg não reagente e anti-HBs reagente; não usa drogas e não tem nova exposição de risco. Quanto ao rastreamento de carcinoma hepatocelular a partir de agora, o exame mais adequado é:

A) Alfafetoproteína semestral

B) Ultrassonografia semestral

C) Nenhum exame de rastreamento

D) Elastografia hepática anual

---

66 Homem de 41 anos, mecânico, é encontrado sonolento na oficina ao lado de um galão sem rótulo, cerca de 20 horas depois de ter sido visto pela última vez. Exame: Glasgow 13, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem queixa visual, fundoscopia normal, FR 30 irpm com respiração profunda, PA 150/90 mmHg. Exames: pH 7,10, bicarbonato 6 mEq/L, pCO2 19 mmHg, sódio 140 mEq/L, cloro 102 mEq/L, glicose 98 mg/dL, ureia 54 mg/dL, creatinina 2,6 mg/dL e subindo, cálcio total 7,3 mg/dL, lactato 2,3 mmol/L, beta-hidroxibutirato 0,3 mmol/L, etanol indetectável, osmolalidade medida de 330 mOsm/kg. O agente mais provável é:

A) Isopropanol

B) Etanol com cetoacidose

C) Etilenoglicol

D) Metanol

---

67 Mulher de 38 anos é trazida à emergência 2 horas após ingerir várias cartelas de um medicamento que usa há 1 ano, em dose baixa à noite, "para a dor da fibromialgia e para dormir". Está sonolenta (Glasgow 12), com pupilas midriáticas, pele quente e seca, mucosas secas, bexiga palpável e ruídos hidroaéreos diminuídos. PA 94 × 58 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 96% em ar ambiente, glicemia 112 mg/dL. ECG: taquicardia sinusal, QRS de 136 ms, onda R de 4 mm em aVR. Gasometria: pH 7,33. A medida mais adequada neste momento é:

A) Bicarbonato de sódio em bolus

B) Fisostigmina intravenosa

C) Lavagem gástrica

D) Flumazenil intravenoso

---

68 Mulher de 79 anos, com diabetes tipo 2 em metformina e gliclazida, é trazida da instituição de longa permanência por sonolência progressiva há quatro dias, após infecção urinária. Exame: Glasgow 11, mucosas muito secas, PA 86/52 mmHg, FC 118 bpm, T 37,8 °C, peso estimado 55 kg. Exames: glicemia 912 mg/dL, sódio 141 mEq/L, potássio 4,9 mEq/L, ureia 128 mg/dL, creatinina 2,3 mg/dL, pH 7,34, bicarbonato 20 mEq/L, beta-hidroxibutirato 0,8 mmol/L, osmolalidade efetiva calculada 333 mOsm/kg. A conduta inicial mais adequada é:

A) SF 0,45% pelo sódio corrigido

B) Bicarbonato e insulina contínua

C) SF 0,9% e, depois, insulina contínua

D) SF 0,9% com insulina em bolus já

---

69 Homem de 45 anos, cerca de 80 kg, com epilepsia em uso irregular de valproato, é trazido pelo SAMU em crise tônico-clônica generalizada que começou há 8 minutos, presenciada pela esposa, sem recuperação da consciência entre os abalos. Na sala de emergência a crise persiste; SpO2 91% com máscara não reinalante, glicemia capilar 112 mg/dL, PA 168/96 mmHg. Após duas tentativas, a equipe ainda não conseguiu acesso venoso periférico. A esposa relata que ele caiu da própria altura no início da crise e bateu a cabeça. A conduta imediata mais adequada é:

A) Fenitoína por acesso intraósseo

B) Diazepam 10 mg intramuscular

C) TC de crânio antes de medicar

D) Midazolam 10 mg intramuscular

---

70 Homem de 38 anos, com úlcera duodenal que sangrou e já foi tratada por endoscopia, recebe concentrado de hemácias. Tem sinusites de repetição desde a adolescência e diagnóstico de doença celíaca há 2 anos. Cerca de 5 minutos após o início da transfusão, apresenta rubor facial, urticária no tronco, rouquidão, sibilos difusos e PA de 70 × 40 mmHg, sem febre, com SpO2 de 89% em ar ambiente. A transfusão é interrompida e ele recebe adrenalina intramuscular, com melhora em minutos. A radiografia de tórax feita a seguir não mostra infiltrados. O diagnóstico e o hemocomponente indicado para transfusões futuras são, respectivamente:

A) TRALI / hemácias lavadas

B) Reação anafilática / hemácias lavadas

C) Reação anafilática / hemácias desleucocitadas

D) TRALI / hemácias desleucocitadas

---

71 Mulher de 42 anos, com HIV e uso irregular da TARV, CD4 64 células/mm³, IgG para toxoplasmose reagente e sem profilaxia, é internada por perda progressiva de força no braço e na perna direitos e dificuldade para falar há 5 semanas, sem cefaleia, febre ou crises. Exame: Glasgow 15, afasia de expressão, hemiparesia direita grau 3, hemianopsia homônima direita, sem papiledema. RM de encéfalo: lesões confluentes da substância branca subcortical frontoparietal e occipital esquerdas, hiperintensas em T2/FLAIR e hipointensas em T1, envolvendo as fibras em U, sem realce pelo gadolínio e sem efeito de massa. O exame mais adequado para confirmar o diagnóstico é:

A) Biópsia cerebral estereotáxica

B) PCR para vírus JC no líquor

C) Prova terapêutica com sulfadiazina

D) PCR para EBV no líquor

---

72 Os padrões tomográficos de doença pulmonar intersticial mais frequentes na artrite reumatoide e na esclerose sistêmica são, respectivamente:

A) Pneumonia intersticial usual / não específica

B) Pneumonia intersticial não específica / usual

C) Pneumonia intersticial não específica / não específica

D) Pneumonia intersticial usual / usual

---

73 Homem de 41 anos, etilista de 60 g/dia, com dor de dente há 3 dias, tomou paracetamol 1 g a cada 3 a 4 horas nesse período, por conta própria, além de dois comprimidos de associação com codeína; a última dose foi há 10 horas. Chega com náuseas e dor em hipocôndrio direito. Exame: anictérico, lúcido, PA 128 × 80 mmHg, FC 96 bpm. Exames: AST 640 U/L, ALT 780 U/L, bilirrubina total 1,2 mg/dL, INR 1,3, creatinina 1,0 mg/dL, glicose 92 mg/dL, pH 7,38, lactato 1,8 mmol/L. Paracetamol sérico de 9 µg/mL, abaixo da linha de tratamento do nomograma de Rumack-Matthew para o horário. Sorologias virais em andamento. A conduta mais adequada é:

A) Não tratar: nível abaixo da linha

B) N-acetilcisteína intravenosa imediata

C) Repetir o nível sérico em 4 horas

D) Aguardar sorologias antes de tratar

---

74 Mulher de 52 anos, professora, que nunca fumou, tem tosse seca e dispneia aos médios esforços há 5 meses, com piora à noite e melhora parcial nas 2 semanas de férias que passou na casa da filha. Há 1 ano trocou o enxoval por edredom e travesseiros de pena de ganso. Nega artralgia, Raynaud, refluxo e uso de medicações. Exame: SpO2 95% em ar ambiente, estertores finos esparsos, sem baqueteamento. TCAR: nódulos centrolobulares mal definidos em vidro fosco, predominando nos terços médios e superiores, com atenuação em mosaico e aprisionamento aéreo na expiração, sem reticulado, bronquiectasias de tração ou faveolamento. FAN e fator reumatoide negativos. CVF 78% do previsto, DLCO 66%. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Afastar as penas e reavaliar

B) Prednisona 0,5 mg/kg/dia

C) Criobiópsia transbrônquica

D) Antifibrótico com nintedanibe

---

75 Homem de 41 anos, com hipertensão há 3 anos, usa losartana 100 mg, anlodipino 10 mg e hidroclorotiazida 25 mg, com adesão confirmada por contagem de comprimidos. PA de consultório 158×98 mmHg e MAPA com média de vigília de 152×96 mmHg. Sem apneia do sono ao questionário e à poligrafia, sem uso de anti-inflamatório ou descongestionante. Exames: sódio 144 mEq/L, potássio 3,2 mEq/L, bicarbonato 30 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, TSH normal. O médico atribui o potássio baixo ao diurético. O próximo passo na investigação é:

A) Relação aldosterona/renina

B) Suspender o tiazídico e repetir o potássio

C) Tomografia de adrenais

D) Doppler de artérias renais

---

76 Homem de 72 anos, no terceiro dia de pós-operatório de colectomia direita com ileostomia, teve hipotensão no intraoperatório (PAM de 58 mmHg por cerca de 40 minutos). Desde ontem recebe furosemida 40 mg IV de 12 em 12 horas por edema de membros inferiores, com albumina de 2,4 g/dL. O débito da ileostomia foi de 1.800 mL nas últimas 24 horas. Exame: PA 102/60 mmHg, FC 106 bpm, mucosas secas, sem turgência jugular, sem estertores, edema 2+, abdome flácido. Exames: creatinina de 0,9 para 2,3 mg/dL, ureia 112 mg/dL, sódio 134 mEq/L; urina com densidade 1,024, cilindros hialinos, sem cilindros granulosos ou células tubulares; fração de excreção de sódio 2,6% e fração de excreção de ureia 24%. A causa mais provável da lesão renal é:

A) Lesão pré-renal por hipovolemia

B) Necrose tubular aguda isquêmica

C) Nefrite intersticial aguda

D) Síndrome compartimental abdominal

---

77 Homem de 49 anos, com diabetes tipo 2, hipertensão, hipertrigliceridemia e IMC de 34 kg/m², bebe cerca de seis doses de destilado por dia há dez anos. É encaminhado por ferritina elevada em exames de rotina. Nega transfusões, história familiar de hepatopatia ou de hemocromatose, artralgia ou disfunção erétil. Exame: circunferência abdominal de 112 cm, fígado palpável a 3 cm do rebordo, sem estigmas de cirrose. Exames: hemoglobina 15,1 g/dL, VCM 101 fL, AST 46 U/L, ALT 50 U/L, GGT 410 U/L, plaquetas 290.000/mm³, PCR 6 mg/L, ferritina 1.180 ng/mL, ferro sérico 74 µg/dL, capacidade total de ligação do ferro 352 µg/dL. Ultrassonografia: esteatose acentuada, sem sinais de hipertensão portal. A conduta mais adequada em relação à ferritina é:

A) Flebotomias semanais

B) Ressonância magnética com quantificação de ferro

C) Abstinência alcoólica e controle metabólico

D) Pesquisa das mutações C282Y e H63D

---

78 Engenheiro de 42 anos retornou há 12 dias de 3 meses de trabalho em Luanda, Angola, sem quimioprofilaxia. Teve malária por Plasmodium vivax há 6 anos, quando morava em Manaus, tratada com cloroquina e primaquina. Há 4 dias tem febre com calafrios, cefaleia e mialgia. Está lúcido e aceita líquidos e comprimidos, sem vômitos. Exame: T 39,2 °C, FC 112 bpm, PA 114 × 70 mmHg, Glasgow 15, ictérico 2+/4+, baço palpável, sem sangramentos. Urinou cerca de 400 mL nas últimas 24 horas. Hb 9,6 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, glicemia 88 mg/dL, creatinina 3,4 mg/dL, bilirrubina total 4,8 mg/dL, lactato 1,8 mmol/L. Gota espessa: numerosos trofozoítos jovens em anel, parasitemia estimada de 6%, sem formas maduras no sangue periférico. A espécie mais provável e o tratamento inicial são, respectivamente:

A) P. falciparum / artesunato intravenoso

B) P. falciparum / artemeter-lumefantrina oral

C) P. vivax / cloroquina e primaquina

D) P. vivax / artesunato intravenoso

---

79 Homem de 66 anos com cirrose por álcool (abstinente há 3 anos), Child-Pugh B8 e MELD 14, tem insuficiência tricúspide importante e FE de VE de 60% ao ecocardiograma; o cateterismo cardíaco direito mostrou pressão média da artéria pulmonar de 48 mmHg. Há 5 meses a ascite volta a exigir paracentese de grande volume a cada 3 semanas, apesar de restrição de sódio, e ele não tolera espironolactona acima de 100 mg/dia por hiponatremia (sódio 128 mEq/L). Sem encefalopatia prévia e sem sangramento. Exame: PA 102 × 64 mmHg, turgência jugular a 45 graus com onda v proeminente, ascite volumosa, edema de membros inferiores 2+. Exames: bilirrubina 1,8 mg/dL, creatinina 1,1 mg/dL, plaquetas 92.000/mm³. Doppler sem trombose portal. A conduta mais adequada para a ascite é:

A) Paracenteses seriadas com albumina

B) Shunt peritoneovenoso

C) TIPS com prótese recoberta

D) Furosemida em dose dobrada

---

80 Mulher de 27 anos procura o ambulatório por visão dupla ao olhar para os lados há 5 dias. Há 1 ano teve perda visual dolorosa no olho esquerdo, com recuperação espontânea em 6 semanas, sem investigação. Nega cefaleia, ptose e piora ao fim do dia. Exame: no olhar para a esquerda, o olho direito não ultrapassa a linha média, e o olho esquerdo abduz com nistagmo; no olhar para a direita, os movimentos são completos e conjugados. A convergência é normal, com adução completa do olho direito. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose, força e reflexos normais. A topografia da lesão e a etiologia mais provável são, respectivamente:

A) FLM esquerdo / desmielinizante

B) FLM esquerdo / isquêmica

C) FLM direito / desmielinizante

D) FLM direito / isquêmica

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 3

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1 (A) (B) (C) (D)	2 (A) (B) (C) (D)	3 (A) (B) (C) (D)	4 (A) (B) (C) (D)
5 (A) (B) (C) (D)	6 (A) (B) (C) (D)	7 (A) (B) (C) (D)	8 (A) (B) (C) (D)
9 (A) (B) (C) (D)	10 (A) (B) (C) (D)	11 (A) (B) (C) (D)	12 (A) (B) (C) (D)
13 (A) (B) (C) (D)	14 (A) (B) (C) (D)	15 (A) (B) (C) (D)	16 (A) (B) (C) (D)
17 (A) (B) (C) (D)	18 (A) (B) (C) (D)	19 (A) (B) (C) (D)	20 (A) (B) (C) (D)
21 (A) (B) (C) (D)	22 (A) (B) (C) (D)	23 (A) (B) (C) (D)	24 (A) (B) (C) (D)
25 (A) (B) (C) (D)	26 (A) (B) (C) (D)	27 (A) (B) (C) (D)	28 (A) (B) (C) (D)
29 (A) (B) (C) (D)	30 (A) (B) (C) (D)	31 (A) (B) (C) (D)	32 (A) (B) (C) (D)
33 (A) (B) (C) (D)	34 (A) (B) (C) (D)	35 (A) (B) (C) (D)	36 (A) (B) (C) (D)
37 (A) (B) (C) (D)	38 (A) (B) (C) (D)	39 (A) (B) (C) (D)	40 (A) (B) (C) (D)
41 (A) (B) (C) (D)	42 (A) (B) (C) (D)	43 (A) (B) (C) (D)	44 (A) (B) (C) (D)
45 (A) (B) (C) (D)	46 (A) (B) (C) (D)	47 (A) (B) (C) (D)	48 (A) (B) (C) (D)
49 (A) (B) (C) (D)	50 (A) (B) (C) (D)	51 (A) (B) (C) (D)	52 (A) (B) (C) (D)
53 (A) (B) (C) (D)	54 (A) (B) (C) (D)	55 (A) (B) (C) (D)	56 (A) (B) (C) (D)
57 (A) (B) (C) (D)	58 (A) (B) (C) (D)	59 (A) (B) (C) (D)	60 (A) (B) (C) (D)
61 (A) (B) (C) (D)	62 (A) (B) (C) (D)	63 (A) (B) (C) (D)	64 (A) (B) (C) (D)
65 (A) (B) (C) (D)	66 (A) (B) (C) (D)	67 (A) (B) (C) (D)	68 (A) (B) (C) (D)
69 (A) (B) (C) (D)	70 (A) (B) (C) (D)	71 (A) (B) (C) (D)	72 (A) (B) (C) (D)
73 (A) (B) (C) (D)	74 (A) (B) (C) (D)	75 (A) (B) (C) (D)	76 (A) (B) (C) (D)
77 (A) (B) (C) (D)	78 (A) (B) (C) (D)	79 (A) (B) (C) (D)	80 (A) (B) (C) (D)